

Définitions

- **Subluxation** : la tête fémorale n'est pas au fond du cotyle, elle est latéralisée et ascensionnée sans être en dehors de l'acétabulum
- **Luxation vraie** : la tête fémorale est en dehors de la cavité cotyloïdienne ou acétabulum
- **Dysplasie** : défaut de développement de la hanche d'expression surtout radiologique ou échographique. La hanche est en place mais l'acétabulum est insuffisamment recouvrant (dysplasie acétabulaire)

Epidémiologie :

- Régions plus touchées : Maghreb, kabylie (Algérie), Bretagne (France)
- Race blanche +++
- Sexe : fille ++++
- Jumeaux monozygotes : 43% concerne les 2 enfants
- FDR : **présentation de siège ++++**, primiparité, haut poids de naissance... (fœtus à l'étroit dans l'utérus)
- Luxations unilatérales plus fréquentes : côté gauche 2 fois plus
- **Déformations associées** : **torticollis congénital, Plagiocéphalie (hémicrane plat), Pied talus**

Pathogénie :

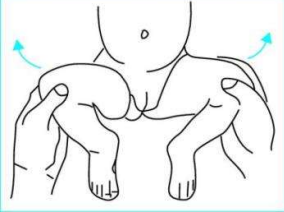
- **Ancienne conception** : dysplasie luxante progressive
- **Conception actuelle (SERINGE)** : **POSTURE LUXANTE** qui se constitue les derniers jours de la grossesse

CLINIQUE :

- ▶ **Inspection** : perte du fessum physiologique, raccourcissement d'un membre, asymétrie des plis fessiers, boiterie chez le grand enfant
- ▶ **Etude de l'abduction** : Bilatérale et symétrique, hanches flechies à 90°
 - Amplitude d'**abduction** < 60° → **Abduction limitée**
 - Tonus des **adducteurs** (stretch reflex) < 20-40° → hypertonie
- ▶ **Instabilité** : **maître symptôme de la LCH : signe de ressaut (Ortolani), signe de piston (Barlow)**

1) Manœuvre d'ORTOLANI (LE DAMANY) : pathognomonique +++

Écartement puis rapprochement cuisses : signe du ressaut

	
Ressaut de rentrée	Ressaut de sortie
La hanche est luxée mais réductible	La hanche est en place mais luxable

Signe DU RESSAUT : correspond au franchissement du bord **postéro-supérieur de l'acétabulum**.

- Disparaît si l'obstacle est complètement émuoussé
- Décelable moins 1/3 des cas

2) Manœuvre de BARLOW : plus sensible et plus précis, signe de piston (pas de ressaut ++++)**Au terme de l'examen clinique:**

1. Hanche normale
2. Hanche luxable
3. Hanche luxée réductible
4. Hanche suspecte : hypertonie, limitation abduction mais absence de signes d'instabilité → **rechercher une hanche à risque**

Une hanche à risque :

1. ATCD familial de LCH au 1^{er} degré (fratrie, parents)
2. Anamnèse : présentation en siège ou autre anomalie
3. Anomalies orthopédiques associées : torticollis, Genu recurvatum
4. Anomalies cliniques : limitation abduction, hypertonie adducteurs

EXAMENS COMPLEMENTAIRES :

Echographie ++++++ : Hanche à risque, hanche douteuse : **1^{er} mois**

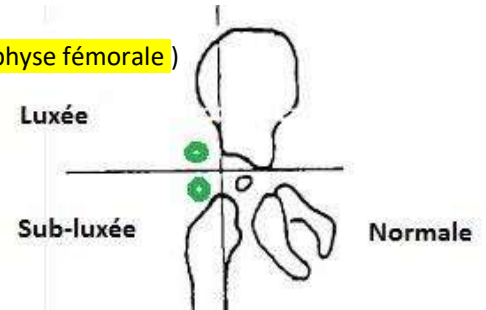
Critères de normalité : degré de couverture TF (50%), Inclinaison du labrum ($\beta = 35^\circ$)

3 éventualités :

- hanche stable
- hanche luxée nette
- hanche douteuse: **refaire examen et Rx à 4 mois**

Radio bassin (face stricte) : à partir du **4^{ème} mois** (apparition du noyau de l'épiphyse fémorale)

- Hanche normale : noyau épiphysaire dans le **quadrant inféro-interne**
- Hanche sub-luxée : noyau épiphysaire dans le quadrant inféro-externe
- Hanche luxée : noyau épiphysaire dans le quadrant supéro-externe



TRAITEMENT :

TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE

Réduction : FLEXION – ABDUCTION- ROTATION INTERNE

NNé	2- 6mois	03 mois – âge de la marche	Grand enfant
Langeage en abduction ou Culotte d'abduction Pendant 4 mois 	Harnais de PAVLIK pendant 4 à 6 mois 	Méthode de SOMMERVILLE 1. Traction lente en abduction RI 5 à 6 semaines 2. Suivie par un plâtre pelvi-pédieux pdt 4 à 6 mois	Attelles à hanche libre (P.PETIT) 1 ^{ère} intention si subluxation En relais d'une autre méthode si luxation

Traitement chirurgical :

- Indications : luxation irréductible, échec du traitement orthopédique
- Abord antérieur : arthrotomie, réduction + capsuloraphie, ostéotomies pelviennes / fémorales
- Plâtre pelvi-pédieux (45J)

COMPLICATIONS :

- ✓ **Relaxation** surtout après réduction chirurgicale
- ✓ **Subluxation résiduelle**
- ✓ **Fracture du fémur** : immobilisation prolongée
- ✓ **Coxarthrose : raideur de hanche** surtout après chirurgie
- ✓ **Ostéochondrite post réductionnelle** : complication la plus grave. Origine vasculaire : atteinte du noyau épiphysaire, génératrice d'une coxarthrose précoce

Fich Flach :

- ♥ Pas de traitement préventif → dépistage systématique pour traitement précoce
- ♥ L'échographie n'est pas un moyen de dépistage : pas systématique
- ♥ Luxation vraie : position du noyau épiphysaire à la Rx kima traumatique (iliaque) = supéro-externe
- ♥ Subluxation : inféro-ext
- ♥ Normale : inféro-interne